ÉCOLE D'ÉCONOMIE
Université Clermont Auvergne

Année académique : 2026-2027

UE221 : EVALUATION EN SANTE

Master 2 : Economie de la santé

RÉALISÉE PAR : **N'douffou Adjoua Souraley Ruth Pamela**

Nom de l'enseignant : GERBAUT LAURENT

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE – ECOLE D'ECONOMIE

Table des matières

TEMPS 1 1

I. À quoi sert la maternité ? 1

I. Pourquoi réaliser ces soins dans une maternité et pas ailleurs ? 1

II. Comment mesurer si la structure atteint – elle ses objectifs ? 1

TEMPS 2 : CRITERES ET INDICATEURS D'EVALUATION DE LA MATERNITE 2

CLASSIFICATION DES INDICATEURS 6

TEMPS 1

I. À quoi sert la maternité ?

La maternité est une structure de soins qui offre des soins maternels et infantiles.

Sa mission principale est la prise en charge des femmes enceintes avant, pendant et après la grossesse, ainsi que des nouveau-nés. Cette structure permet d'offrir des soins préventifs et/ou curatifs aux mères ainsi qu'aux nouveau-nés. Ils prennent également en charge toutes les complications qui pourraient subvenir et interviennent en cas d'urgence.

I. Pourquoi réaliser ces soins dans une maternité et pas ailleurs ?

Ces soins sont réalisés en maternité car, contrairement aux autres structures, la maternité offre des soins spécifiques aux femmes enceintes ainsi qu'aux nouveau-nés. Ces soins sont en général la prise en charge de l'accouchement, des complications obstétricales, pédiatriques etc.

II. Comment mesurer si la structure atteint – elle ses objectifs ?

Nous pourrons vérifier par plusieurs moyens la manière dont la maternité atteint ses objectifs :

1. **La disponibilité du personnel qualifié** : la maternité doit disposer de suffisamment de professionnels de santé bien formés et qualifiés afin d'assurer une meilleure prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.

2. **La disponibilité des équipements et des médicaments** : vérifier le fonctionnement des équipements médicaux, des plateaux techniques, des sanitaires etc. De plus, la disponibilité des médicaments essentiels pour faciliter la meilleure prise en charge des femmes en cas d'urgences.
3. **La fréquence des complications maternelles :** il s'agit d'évaluer le taux de complications survenues pendant la grossesse notamment, les hémorragies et les infections. Également le taux de mortalité et de QUALYS (Quality-Adjusted Life Year).

En outre, évaluer si une maternité atteint ses objectifs consiste à mesurer des indicateurs. Dans notre travail, ces indicateurs seront classés par catégories :

- **Les structures** : pour la gestion des locaux, des équipements et des ressources humaines de la maternité.
- **Les procédures** : concernera l'organisation et la réalisation des soins
- **Les résultats et la performance** : évalueront les conséquences des soins sur la mère et le nouveau-né.
- **L'évaluation et la politique qualité** : ces catégories correspondent aux démarches mises en place pour améliorer la qualité des soins.

TEMPS 2 : CRITERES ET INDICATEURS D'EVALUATION DE LA MATERNITE

Indicateur 1 : La disponibilité du personnel qualifié

Critère : la densité des sage-femmes

Cet indicateur indique le nombre de maïeuticiens disponibles susceptibles d'assurer le suivi de la grossesse, l'accouchement et le suivi postnatal des femmes.

Mode de recueil : Pour mesurer l'offre de soins en maïeutique, il est possible d'utiliser les données sur le recensement du nombre de sage-femmes exerçant dans la maternité sur un territoire donnée. À ces données seront associées les données démographiques de l'INSEE [1] pour déterminer la population résidente.

Méthode de calcul : La densité des sage-femmes se calcule en divisant le nombre de sage-femme exerçant dans une zone géographique donnée par la population totale de cette zone, puis en multipliant le résultat par 100 000.

Exemple : Le ratio de sage-femmes peut être calculé en rapportant le nombre de sage- femmes à la population desservie. Par exemple, si une maternité compte 50 professionnels de soins et dessert une population de 75 000 habitants, la densité est calculée de la manière suivante. (50 /75 000) *100 000, soit 66,7 sage-femmes pour 100 000 habitants.

Indicateur 2 : l'existence d'un comité qualité fonctionnel

Critère : Constater l'existence et la fonctionnalité du comité qualité.

Le comité consiste à instituer et assurer le pilotage des démarches qualité de la maternité. Il est considéré comme fonctionnel s'il existe une composition pluridisciplinaire notamment, les sage-femmes, les gynécologues, le cadre de santé, la direction etc. De plus, ces réunions doivent être réalisées au moins 4 fois dans l'année.

Mode de recueil : les données seront recueillies à partir des entretiens avec les responsables qualité, les analyses documentaires, les comptes rendus écrits ou verbales des réunions ou session d'échanges.

Méthodes de calcul : Le taux de conformité du comité qualité = (nombre de critères respectés/ 4) * 100.

Prenons un exemple avec les 4 critères du comité

- Existence du comité : Oui
- Composition pluridisciplinaire : Oui

[1] **Institut national de la statistique et des études économiques.** Elle collecte, produit, analyse et diffuse des informations sur la population française, notamment grâce au recensement de la population et aux statistiques d'état civil (naissances, décès, mariages).

- Réalisations de 4 réunions/an : Oui
- Des comptes rendus disponibles : Non

$$\frac{3}{4} \times 100 = 75\%$$

Indicateur 3 : Taux de complications maternelles

Critère : la prise en charge obstétricale

Cet indicateur mesure la fréquence des complications maternelles graves survenues avant, pendant et après l'accouchement.

Mode de recueil : Les registres de maternités, les dossiers médicaux et les comptes rendus d'hospitalisations seront examinés pour identifier les cas de complications.

Méthode de calcul : le taux de complications maternelles graves = (nombre de femmes ayant présenté au moins une complication grave pendant la période étudiée/ nombre total de mères présentes dans la maternité à cette période).

Indicateur 4 : Le taux de mortalité néonatale précoce

Cet indicateur désigne les décès des enfants nés vivants survenant avant 7 jours de vie.

Les périodes d'observations doivent être conformes aux recommandations épidémiologiques de la maternité.

Mode de recueil : pour recueillir les données il faudra consulter les registres de naissances, les dossiers pédiatriques, les registres d'accouchements et les registres de décès. Ces données permettront de vérifier les naissances vivantes et les décès survenues pendant la période d'observations définies.

Méthode de calcul : le taux de mortalité néonatale précoce = (nombre de décès de nouveaux nés survivants avant le septième jour/ nombre total de naissances vivantes) *1000

Indicateur 5 : La fréquence de participation aux formations continues

Critère : la qualification et l'amélioration des compétences du personnel

Cet indicateur permet de mesurer la fréquence à laquelle les maïeuticiens (sage-femmes) travaillant dans la maternité participent à des formations continues afin d'actualiser leurs connaissances et leurs compétences professionnelles.

Mode de recueil : Ces données seront collectées à partir des attestations d'inscriptions ou de participation aux formations.

Méthode de calcul : Le taux de participation à la formation continue = (nombre de sage - femmes ayant suivi au moins une formation au cours de l'année / nombre total de sage-femmes exerçant dans la maternité à une année donnée) *100.

L'idée est de connaître le nombre moyen de sage – femme participant à des formations continues par an.

Indicateur 6 : La satisfaction des patientes (femmes enceintes)

Critère : La qualité de l'accueil et la prise en charge des femmes enceintes

Cet indicateur permet d'évaluer le niveau de satisfaction des femmes enceintes lors des consultations ou de leur prise en charge en maternité. Il capte aussi la qualité des soins et les conditions d'hospitalisations.

Mode de recueil : les informations à ce sujet seront recueillies à l'aide de questionnaires de satisfaction de façon anonyme remis aux patientes ou leurs proches après les soins ou l'accouchement. Elles peuvent être récoltées par des entretiens groupés semi-directifs ou directifs afin de révéler le niveau de satisfaction des femmes.

Méthode de calcul : Le taux de satisfaction des patientes (%) = (Nombre de patientes ayant déclaré être satisfaites / Nombre total de répondants) × 100.

Exemple : sur 200 patientes ayant répondu au questionnaire, 85 déclarent être satisfaites de leur prise en charge.

Taux de satisfaction = (85 / 200) × 100 = 42,5 %.

Indicateur 7 : Le taux de césariennes

Critère : La pertinence des pratiques obstétricales dans le choix du mode d'accouchement.

Mode de recueil : les données seront extraites des registres d'accouchements et des dossiers obstétricaux sur une période donnée (1 an).

Méthode de calcul : le taux de césariennes = (nombre d'accouchements par césarienne/ nombre total d'accouchements) *100

Indicateur 8 : Le taux d'évènements indésirables

Critère : la capacité de la maternité à repérer, analyser et prévenir les évènements indésirables associés aux soins maternelles et infantiles ainsi que la mise en place des stratégies d'améliorations.

Méthode de calcul : le taux d'événements indésirables (%) = (nombre d'événements indésirables analysés/ nombre total d'événements indésirables déclarés) *100

Exemple : Si sur 40 événements indésirables (erreur d'identification ou de traitement etc.) déclarés en trois mois, 16 ont fait l'objet d'une analyse.

Le taux d'analyse = (16 / 40) × 100 = **40 %**.

Indicateur 9 : Le taux de satisfaction des sage-femmes

Critère : évaluer la qualité des conditions de travail et la satisfaction du personnel de la maternité.

Méthode de recueil : pour connaitre le taux de personnel satisfait par la politique de la maternité, une enquête anonyme peut être réalisée auprès du personnel de la maternité (sage-femmes, infirmiers et les aides-soignants), afin de détecter les conditions de travail, la disponibilité du matériel médical, la charge au travail et les relations professionnelles.

Méthode de calcul : Le taux de satisfaction du personnel = (nombre de professionnels satisfaits/ nombre total de répondants) *100

Un taux inférieur à 50 % signifie qu'il existe des difficultés dans le déploiement de la politique qualité.

Un taux situé entre 70 et 80 % traduit plutôt une satisfaction importante du personnel.

Indicateur 10 : l'existence d'une organisation de gestion des risques

L'objectif de cet indicateur est vérifié par la mise en place d'une structure et des procédures permettant d'identifier, analyser, prévenir et gérer les risques pouvant affecter la mère, le nouveau-né ou les professionnels de santé.

Critère : l'existence d'une organisation de gestion des risques

Méthode de recueil : Consulter les documents de la maternité afin de vérifier l'existence d'une organisation de gestion des risques. Cette organisation devrait comprendre des procédures écrites, un responsable désigné puis un dispositif de déclaration et d'analyse des risques.

Méthode de calcul : on peut vérifier l'existence de cet indicateur par des valeurs binaires

1 : si l'organisation de gestion des risques existe

0 : aucune organisation n'existe

CLASSIFICATION DES INDICATEURS

	Performance	Evaluation de la qualité	Politique Qualité
Structure	• La disponibilité du personnel qualifié (sage-femmes)	• L'existence d'un comité qualité fonctionnel	• L'existence d'une organisation de gestion de risques
Procédure	• Le taux de césariennes	• La fréquence de participations aux formations continues	• Le suivi des évènements indésirables
Résultats	• Le taux de complications maternelles • Le taux de mortalité néonatale précoce	• La satisfaction des patientes	• Le taux de satisfaction du personnel